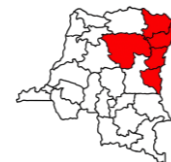




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°116/MVEBDB/08/09/2026

Date de rapportage : 07 septembre 2026

Date de publication : 08 septembre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

En date du 07 septembre 2026, 71 nouveaux cas confirmés dont 31 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (41 cas), du Nord-Kivu (27 cas) et Haut Uélé (3). Cependant, 10 décès intra-CTE ont été également rapportés.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24h.

CUMUL DES CAS 6 757	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 3 267	LETALITE 48,3%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 813	CUMUL DES GUÉRIS 1 590	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 88,3 %
--	--	-------------------------------------	---	---	--



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



61 Zones de santé touchées sur 151 (40,4%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

En date du 07 septembre 2026, **71 nouveaux cas confirmés** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont **31 décès communautaires**. Les provinces ayant notifié cas sont celles de l'Ituri (41 cas), Nord-Kivu (27) et Haut Uélé (3). Cependant, nous déplorons **10 décès intra-CTE** enregistrés dont 9 en Ituri et 1 au Nord-Kivu, portant le nombre des décès du jour à 41.

Au total, **27 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (21 en Ituri, 4 au Haut Uélé et 2 au Nord-Kivu) au cours des dernières 24h.

La RDC cumule **6 757 cas confirmés** dont **3 267 décès** soit une létalité de **48,3 %**. Depuis le début de l'épidémie, la province de l'Ituri demeure l'épicentre concentrant **80,0 %** des cas confirmés rapportés à travers les 6 provinces affectées. De plus, elle détient **57,7 %** des nouveaux cas.

Fort heureusement, aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures. Ainsi, **61 zones de santé sur 151 (40,4%)** restent affectées dans les 6 provinces touchées. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (16/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) ainsi que le Bas Uélé (3/11).

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 07 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	41	5406	2 450	45,3%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	27	1066	697	65,4%	16/34 (47,0 %)
Haut-Uélé	3	256	107	41,8%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	0	22	9	40,9%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	4	3	75,0%	3/11(27,3%)
Total	71	6 757	3 267	48,3%	61/151 (40,4 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 07 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5406	2450	45,3%	41	15	9	24
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	176	39	22,2%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1502	471	31,4%	14	7		7
Damas	30	9	30,0%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	78	30	38,5%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	33	12	36,4%				0
Komanda	117	79	67,5%	4	4		4
Lita	245	122	49,8%	3	1		1
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	25	7	28,0%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	42	23	54,8%	1	0		0
Mangala	295	141	47,8%	5	0		0
Mongbwalu	638	291	45,6%	4	1		1
Nia-Nia	227	115	50,7%	1	0		0
Nizi	709	273	38,5%	2	0		0
Nyankunde	125	36	28,8%				0
Rimba	11	4	36,4%				0

Rwampara	992	347	35,0%	5	2		2
Tchomia	62	25	40,3%	2	0		0
A ventiler	NA	387	NA	0	0	9	9
Nord-Kivu	1066	697	65,4%	27	15	1	16
Beni	181	135	74,6%	5	3		3
Biena	9	4	44,4%				0
Butembo	211	146	69,2%	3	2		2
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	18	9	50,0%				0
Katwa	468	302	64,5%	11	5	1	6
Kayna	1	0	0,0%				0
Kyondo	23	15	65,2%				0
Lubero	6	4	66,7%				0
Mabalako	10	7	70,0%				0
Manguredjipa	4	3	75,0%	1	1		1
Masereka	15	6	40,0%				0
Musienene	100	54	54,0%	6	4		4
Mutwanga	2	2	100,0%				0
Oicha	9	6	66,7%				0
Vuhovi	8	4	50,0%	1	0		0
Haut-Uélé	256	107	41,8%	3	1	0	1
Boma Mangbetu	29	14	48,3%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	92	37	40,2%				0
Pawa	46	23	50,0%	3	1		1
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	84	31	36,9%				0
Tshopo	22	9	40,9%	0	0	0	0
Bafwasende	2	0	0,0%				0
Kabondo	4	1	25,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	10	5	50,0%				0
Mangobo	3	2	66,7%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	4	3	75,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	1				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	2	2	100,0%				0
Total	6757	3267	48,3%	71	31	10	41

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

** Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 07 Septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	13	4	17	11	4	2	0	15	11
Bas Uélé	15	0	15	4	0	11	0	4	0
Ituri	655	75	730	123	57	294	7	180	105
Nord-Kivu	597	41	638	74	41	509	0	115	31
Sud-Kivu	11	0	11	8	0	3	0	8	6
Tshopo	97	0	97	6	1	85	0	7	1
Total Général	1 388	120	1 508	226	103	904	7	329	154

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

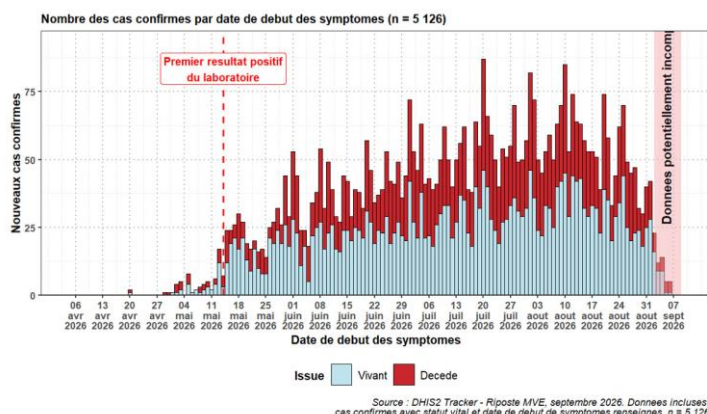
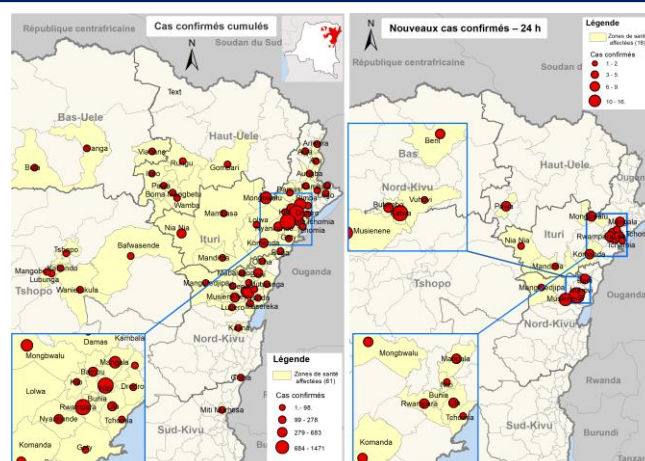


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.
- Cérémonie de déchargement de 22 guéris du CTE d'Isiro sous le patronage du Ministre provincial de la Santé et préparation, auprès de la DGRHU, suivie de la réinsertion professionnelle d'une guérie.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.1. Surveillance épidémiologique

1.1.2. Principales Actions

Au décours de la journée du 07 septembre 2026, 1 508 alertes ont été rapportées dans 6 provinces, 1 240 (82,2%) ont pu être vérifiées. Toutes les 329 alertes validées comme cas suspects ont été investigués (100 %) et 154 d'entre eux ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Des 24 719 contacts à suivre pour la journée du 07 septembre, 21 359 d'entre eux ont été vus, soit une proportion journalière de **88,3 %**, supérieure au seuil de 85 % ; **90,7% en Ituri (12 054/13 289)**, 87,3% au Nord-Kivu (8 580/9 833), 70,4% au Bas Uélé (107/152), 69,5 % à la Tshopo (196/282) et 67,7% au Haut Uélé (422/623)

1.1.3. Défis

Insuffisance des équipes dédiées aux activités de surveillance suivi des contacts rendant inefficace le suivi des contacts particulièrement au Bas Uélé.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

Sept (7) alertes ont été notifiées aux différents PoE/PoC en date du 07 septembre 2026, dont quatre en Ituri, deux au Bas Uélé et une au Nord-Kivu. En Ituri, trois alertes ont été interceptées au PoC Mudzibala (AS Nzere, ZS de Bunia), et toutes ont été validées.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoC/PoE par province, en date du 07 Septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	90% (54/60)	100 % (19/19)	55,5% (5/9)	39% (7/18)	64,0% (7/11)	36% (9/25)	71,1% (101/142)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	146370	87959	11312	3693	11 288	4215	253549
% des voyageurs screenés	98,00%	98,18%	99,00%	99,00%	98,00%	98,8%	98,50%
% des voyageurs ayant lavé les mains	98,00%	98,18%	99,00%	97,5%	98,00%	98,8%	99,09%
% des voyageurs sensibilisés	99,00%	98,18%	100,00%	100,00%	98,00%	95,8%	99,25%
Nombre d'alertes notifiées	4	1	0	0	0	2	7
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	3	0	0	0	0	0	3
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	1	0	0	0	0	1
% des cas suspects transférés au CT/CTE	66,7%	0%	-	-	-	-	66,7%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	-	100%	-	-	-	-	100%
% des cas suspects investigués dans 24 h	100%	100%	-	-	-	100%	100%

1.2.2. Défis

Opérationnalisation des PoE/PoC demeure non optimale : la complétude reste faible au Bas-Uélé (34,6 %, 9 rapports reçus sur 26 attendus), au Sud-Kivu (55,5 %, 5/9) et au Haut-Uélé (64,0 %, 7/11) et connexion internet non fourni dans 4 PoC ; insécurité persistante entravant la mise en service du PoC d'Avakubi (Ituri) ; grève consécutive au non-paiement des prestataires des PoC (Nzebi, Galay, Pluto et Bey) ; à la Tshopo, seuls 18 des 30 PoC planifiés sont activés.

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 41 nouveaux résultats positifs** (26 vivants et 15 décès) sur 279 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 14,7%**).
- **Nord-Kivu : 27 nouveaux résultats positifs** (12 vivants et 15 décès) sur 174 échantillons analysés (**positivité de 15,5%**).
- **Haut-Uélé : 3 nouveaux résultats positifs** (2 vivants et 1 décès) sur 19 échantillons analysés (**positivité : 15,8%**).

- **Bas-Uélé : 3 échantillons** reçus et testés (3 vivants), **tous sont revenus négatifs.**
- **Tshopo : 6 échantillon** reçus et testés (6 vivants), tous sont **revenus négatifs.**

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 25 rings ont été ouverts sur les 70 attendus (35,7 %), 73 ménages décontaminés sur 73 identifiés (100 %) et 10 FOSA décontaminées sur 11 (91,0 %) ; 60 kits PCI ont été dotés aux ménages de la zone de santé de Mongbwalu. Quant aux EDS, 92 alertes ont été enregistrées, 79 EDS réalisées (85,9 %) et 67 corps swabés sur 79.
- **Au Nord-Kivu**, 31 rings ont été ouverts sur les 34 attendus (91,2 %), 13 ménages décontaminés sur 26 identifiés (50,0 %) et 30 FOSA décontaminées sur 42 (71,4 %), sans dotation de kits aux ménages ; 21 évaluations de FOSA ont été réalisées avec un score moyen de 50,8 % ; formation en PCI/WASH des équipes cadres de ZS de Butembo et Katwa ; début de formation de 100 hygiénistes de Butembo, Katwa et Musienene avec l'appui de l'UNICEF. Le pilier EDS a reçu 51 alertes (22 reports de la veille), 50 EDS réalisés et 51 corps swabés (100 %).
- **À la Tshopo**, dotation d'intrants PCI dans 8 ESS des zones de santé de Makiso-Kisangani et de Kabondo ; remplacement d'un matelas à un établissement d'hébergement (ZS de Kabondo, 21^e cas) ; suivi et accompagnement de 14 ESS dans 5 zones de santé (Makiso-Kisangani, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Lubunga) avec le briefing de 125 prestataires sur les mesures PCI ; 2 rings ouverts à Kabondo et à Mangobo.
- **Au Haut-Uélé**, les 6 rings attendus ont tous été ouverts (100 %), 27 ménages décontaminés sur 30 identifiés (90,0 %) et 5 FOSA sur 5 (100 %), 10 ESS accompagnées et 64 prestataires briefés dans les 6 zones de santé touchées ; 5 alertes EDS ont été reçues, 4 EDS réalisés et 5 corps swabés.

1.4.2. Défis

- **En Ituri** : Faible ouverture des rings (35,7 %, 25/70) et insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki, Mangala et Komanda ; Manque de mobilité à Bambu, Mandima ; Non réalisation des activités consécutive à la rupture d'intrants à Mangala et Mandima. **Au Nord-Kivu** : décontamination insuffisante des ménages identifiés (13/26) et les équipes restent à activer et à former à Biena, Masereka, Kyondo, Mabalako et Vuhovi. **À la Tshopo** : insuffisance d'intrants PCI dans les ESS, prestataires non formés et incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani en panne. **Au Haut-Uélé** : indisponibilité persistante des kits ménages limite l'accompagnement et seules 8 des 30 ESS sous surveillance disposent d'une unité de triage fonctionnelle (26,7 %).
- Pour les EDS, corps non swabés en Ituri (Mandima et Fataki), dû à l'absence des équipes, manque d'intrants et 8 au Nord-Kivu (Kalunguta et Vuhovi) par insuffisance de moyens de transport ; persistance du manque de mobilités pour les équipes EDS des ZS de Kilo, Nia-Nia, Mandima et Fataki.

1.5. Prise en charge holistique

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 77 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées contre 88 sorties dont 21 guéris. Ainsi, 473 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 48,4% ; **433/457 (95%)** patients ont bénéficié de repas chaud ; **14/14 (100%)** Enfants sous LNPE/SLM au CTE, **3/3 (100%)** Enfants sous LNPE/SLM à la Crèche et **28/28 (100%)** Enfants sous LNPE/SLM dans la communauté ; poursuite de l'analyse du protocole ORACLE-BDBV pour les essais cliniques d'un candidat traitement (INRB).

- **Au Nord-Kivu**, 74 nouvelles admissions et 91 sorties enregistrées dont 2 guéries ; 254 patients sont hospitalisés exprimant un taux d'occupation global des lits en CTE/CT est en sursaturation (115,5 % ; 220 lits disponibles).
- **Au Haut Uélé**, 11 nouvelles admissions contre 6 sorties (4 guéries). Ainsi, 62 patients sont hospitalisés pour 128 lits, soit un taux d'occupation de 48,4%.
- **À la Tshopo**, deux nouvelles admissions ont été enregistrées et trois sorties (aucun guéri). Quatre (4) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation de 16,0 %.
- **Au Sud-Kivu**, 6 nouvelles admissions au décours de la journée, 20 patients sont en isolement (Taux d'occupation :80,0%).

1.5.2. Défis

Prise en charge encore partiellement hors normes et capacités limitées : **au Nord-Kivu**, 101 des 254 patients hospitalisés (40 %) restent pris en charge dans des structures qui ne sont pas des CTE. **En Ituri**, les CTE/CT de Nizi, Mambasa, Lolwa et Kilo sont saturés du côté des suspects. **Au Haut-Uélé**, le CTE de Pawa manque d'installations hygiéniques et celui d'Isiro d'espace, d'eau et d'électricité en permanence. **À la Tshopo**, l'absence de sang sécurisé et un plateau technique limité pèsent sur la prise en charge. **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE/CT et d'ambulance limite l'isolement des cas.

1.6. Vaccination

1.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, réception de 3 000 doses d'ERVEBO sur 11 000 attendus, décongélation de 500 doses et déploiement de 100 doses à Kabondo, 300 à Makiso-Kisangani et 100 à Mangobo.
- **En Ituri**, tenue d'une réunion d'échange sur la composition, le recrutement et le briefing des acteurs chargés de la vaccination des PPL à Bunia.

1.6.2. Défis

Insuffisance des doses disponibles à la Tshopo (3 000 reçues pour 11 000 exprimées), manque de mobilité pour la recherche des TPL (3 véhicules requis pour la stratégie mobile) et site de vaccination de Bafwasende demeure non activé. **Au Bas-Uélé**, la rupture de stock d'ERVEBO à Buta entraîne une suspension temporaire de la vaccination des PPL et TPL ; absence de micro plans dans les 6 zones de santé prioritaires (Aketi, Ango, Bili, Buta, Ganga et Viadana).

1.7. Continuité des Soins

- **Au Bas-Uélé**, 16 contacts à haut risque demeurent sous prophylaxie post-exposition dans les zones de santé de Buta (10) et de Ganga (6), la province n'ayant pas transmis de rapport actualisé au cours des dernières 24 heures.
- **À la Tshopo**, évaluation du CS Malkia (absence d'eau potable), suivi du lancement du groupe de travail médicament, de la livraison des médicaments essentiels génériques des zones de santé vers les aires de santé.
- **Au Haut-Uélé**, cérémonie de déchargement de 22 guéris du CTE d'Isiro sous le patronage du Ministre provincial de la Santé et préparation, auprès de la DGRHU et réinsertion professionnelle d'une guérie ; 6 autres guéris attendent leur déchargement à Isiro.
- **À la Tshopo**, 3 nouveaux contacts à haut risque ont été mis sous prophylaxie post-exposition, dont 1 prestataire de première ligne, et 2 guéris ont intégré les équipes de riposte.

1.8. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 29 membres de la société civile et des forces vives ont été briefés sur les mesures préventives de la MVE, avec un accent sur les enterrements dignes et sécurisés et l'appui de World Vision ; 17 258 visites à domicile ont touché 29 803 personnes, 566 causeries éducatives 9 915 personnes, 4 débats communautaires 45 personnes et 24 actions de sensibilisation de masse 1 841 personnes ; 53 contacts ont été pré-listés autour des cas confirmés à Komanda.
- **Haut Uélé** : Plaidoyer auprès de Son Excellence Mr le Ministre Provincial de la communication pour l'accompagnement des activités de la riposte contre la MVE par les Médias à travers toute la province ; 8 activités de masse ont touché 2 395 personnes, 76 visites à domicile 456 personnes et 60 causeries éducatives 433 personnes.
- **À la Tshopo**, 4 270 personnes ont été sensibilisées, dont 2 880 élèves de 4 écoles de Kisangani, 796 personnes lors des visites à domicile dans 156 ménages des zones de santé de Mangobo et de la Tshopo, 392 lors d'une parade et 46 au cours d'un dialogue communautaire autour du CTE de Météo en construction ; 2 feedbacks ont été résolus et 1 incident levé.

1.8.2. Défis

Persistance des résistances communautaires : **à la Tshopo**, une attaque contre les équipes a été enregistrée dans l'AS de Bethsaïda (ZS de Mangobo) sur fond de rumeurs « Ebola business », 11 contacts refusent le suivi dans l'AS de Matete (ZS de Mangobo) et un refus de prélèvement a pu être levé par la négociation à Kumbakisaka. **Au Haut-Uélé**, un refus de dénombrement persiste à Tely (ZS d'Isiro), la rumeur selon laquelle les malades seraient enfermés sous les tentes de l'HGR d'Isiro circule, rupture d'affiches et de dépliants. **En Ituri**, des résistances aux EDS sont rapportées à Bunia, Nizi, Nia-Nia et Aru. **Au Nord-Kivu**, un cas confirmé s'est évadé après confirmation à Masereka et une famille de Munzambaye (ZS de Butembo) refuse la décontamination de son ménage.

1.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.9.1. Principales actions

- **En Ituri**, 19 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 147 des 195 cas suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 73 annonces de résultats réalisées dont 19 positifs, 16 PPL soutenus et 43 ménages accompagnés 49 enfants et 35 guéris suivi dans la communauté.
- **Au Nord-Kivu**, 29 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 165 cas confirmés en cours de suivi ont été pris en charge, ainsi que 67 nouveaux suspects ; 105 annonces de résultats dont 39 positives, 56 PPL soutenus, 67 ménages accompagnés, 11 des 14 guéris suivis.
- **À la Tshopo**, 2 cas confirmés et 4 cas suspects ont bénéficié d'un soutien psychologique, 3 annonces de résultats toutes négatives, 22 accompagnants et 11 PPL soutenus et 44 personnes touchées par des séances de psychoéducation.
- **Au Haut-Uélé**, 5 nouveaux cas confirmés et 36 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 5 nouveaux suspects et 32 suspects en cours de suivi ; 20 annonces de résultats dont 5 positives ; 89 accompagnants, 78 PPL et 4 membres de familles soutenus, et le déchargement des 22 guéris d'Isiro accompagné

1.9.2. Défis

En Ituri, Faible couverture des interventions SMSPS autour des derniers cas confirmés en Ituri (Komanda et Lita) et au Nord-Kivu (Biena, Manguredjipa, Kayna, Lubero, Masereka, Kalunguta, Mabalako, Mutwanga et Vuhovi), où les crèches font défaut dans 10 zones de santé affectées. **Au Haut-Uélé**, insuffisance de personnel et de moyens de mobilité (Boma Mangbetu et Wamba) et absence de prestataires SMSPS à la Tshopo (Bafwasende, Wanierukula et Isangi).

1.10. Logistique

1.10.1. Principales actions

- **En Ituri**, 16 des 32 transferts de patients organisés ont abouti (50 %) et 25 patients ont été évacués ; appui alimentaire à 433 des 457 patients hospitalisés (95 %), 14 enfants sous LNPE/SLM au CTE (100 %), 3 en crèche et 28 dans la communauté ; 2 ambulances sont mobilisées (1 à Bambu et 1 à Nizi) et des besoins alimentaires subsistent à Kilo (5), Lolwa (13), Mambasa (4) et Mandima (2).
- **Au Nord-Kivu**, 14 appels reçus pour 14 courses réalisées et toutes réussies (100 %) et 9 ambulances mobilisées sur les 11 disponibles (82 %) ; 93 des 93 malades (100 %) et 41 accompagnants ont bénéficié d'un repas chaud, 2 confirmés instables ont reçu un régime alimentaire spécifique au CTE de Beni et 129 prestataires de première ligne ont été restaurés ; réception de 139 colis d'intrants.
- **Au Haut-Uélé**, 46 patients, 70 accompagnants et 25 PPL ont bénéficié de trois repas chauds ; réception de 4 réfrigérateurs pour les laboratoires d'Isiro et de Wamba, de 150 palettes et de 2 bâches pour les tentes UMS ; livraison des EPI à la ZS de Pawa et don de 1 500 litres de carburant par MEMISA.
- **À la Tshopo**, suivi de la construction des CTE de Météo et de Bafwasende et déploiement de 3 camions de médicaments (11 tonnes) à Lubunga.

1.10.2. Sécurité

1.10.3. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, six activités de maintien de la discipline populaire ont été réalisées dans la sous-coordination de Beni : accompagnement et couverture sécuritaire des équipes PCI au CS Amani (AS de Bundji), au CS Shamamba et au dispensaire Sifa (AS de Benengule), au CH Paida (AS de Paida) et dans un ménage de l'AS de Rwangoma pour la décontamination, ainsi que de l'équipe EDS pour l'inhumation de 3 corps confirmés aux cimetières de Bundji et de Masiani ; toutes ces activités ont été couvertes à 100 %. Un accompagnement sécuritaire a également été assuré à Oicha pour l'étude de faisabilité d'un site d'isolement et d'un CTE normé à l'HGR.

1.10.4. Défis

Au Nord-Kivu, manque d'un véhicule permanent pour l'équipe de sécurité et absence de motivation pécuniaire des agents ; nécessité d'informer systématiquement l'équipe de sécurité avant toute descente sur le terrain.

1.11. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.11.1. Principales actions.

- **En Ituri**, briefing de 61 prestataires (RECO, PRESICOSA et infirmiers titulaires) de la zone de santé de Mambasa, dont 41 femmes et 20 hommes, et poursuite de l'affichage des messages et de la distribution de dépliants PSEAH dans les zones de santé de Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki.
- **Au Haut-Uélé**, briefing des personnes de première ligne sur l'importance du signalement aux numéros verts 495555 et 151 et sensibilisation communautaire dans les zones de santé d'Isiro (160 relais communautaires dont 108 hommes et 52 femmes), de Wamba (476 personnes), de Boma Mangbetu (70), de Gombari (55 élèves) et de Rungu (5), soit 745 personnes sensibilisées ; 5 des 6 zones de santé touchées (83,3 %) connaissent désormais le mécanisme de signalement.

1.11.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA, seules 13 des 36 zones de santé de l'Ituri (36,1 %) connaissant le mécanisme de signalement ; absence de cartographie des intervenants et refus d'alignement de certains partenaires ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de kits informatiques et de fournitures de bureau pour le pilier.

MESSAGES CLES

- Consolidation des progrès en matière d'investigations épidémiologiques (**100 % des cas suspects investigués**) et une stabilité de la proportion journalière du suivi des contacts (**88,3%**) **au-dessus du** seuil de 85,0%.
- Cependant, la notification continue dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Haut-Uélé met en exergue une transmission soutenue de la maladie au niveau communautaire). La province du Nord-Kivu présente un profil préoccupant bien au-delà de sa létalité élevée caractéristique, **38,0%** des nouveaux cas confirmés y ont été rapportés contre **47,6%** la veille.
- En date du 07 septembre 2026, **71 nouveaux cas confirmés** dont **31 décès communautaires et 10 intra-CTE** ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à **6 757 cas confirmés et 3 267 décès (létalité : 48,3%)**.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **80,0 %** des cas confirmés cumulés et **57,7%** des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission : Augmenter rapidement les capacités d'accueil dans les CT/CTE au Nord-Kivu.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd